

| SH.GSR.09.CSS.03                           |                              |            | رقم السياسة                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تفادي التوصيل غير السليم للقساطر والأنابيب |                              |            | عنوان السياسة                                                                                                        |
| ٢                                          | رقم الإصدار                  | ٢٠٢٦/٠٣/٠١ | تاريخ إعداد                                                                                                          |
| ٢٠٢٦/٠٤/٠١                                 | تاريخ اعتماد                 | ٢٠٢٦/٠٤/٠١ | تاريخ تفعيل                                                                                                          |
| ٧                                          | عدد الصفحات                  | ٢٠٢٩/٠٤/٠١ | تاريخ المراجعة                                                                                                       |
| جميع الاقسام بالمستشفى                     |                              |            | نطاق التفعيل                                                                                                         |
| اعتماد                                     | مراجعة                       |            | إعداد                                                                                                                |
| مدير المستشفى<br>د/ وسام وهيبه             | لجنة الجودة<br>د/ ايمان سامي |            | مدير الشؤون العلاجية<br>د/ محمد مختار<br>رئيسة التمريض<br>م/ هيام محمود<br>فريق الجودة<br>د/ باسل محمد - م/ ولاء سيد |



د/ ايمان سامي السيد  
 مديرة الجودة  
 مستشفى صيدناوى

## السياسة

- يلتزم الفريق الطبي (الأطباء والتمريض) بمستشفى صيدناوى بتنفيذ عملية محددة للتعامل الآمن مع الوصلات المتصلة بالمريض سواء داخل أو خارج المريض بطريقة سليمة لضمان سلامة وأمان المريض من أي خطر من الممكن أن يتعرض له.
- لا يحق للمرضى، أو أسرهم أو العاملين بالمستشفى غير الفريق الطبي فصل أو تركيب أو إعادة تركيب أي نوع من أنواع الأنابيب أو القساطر ويعد تثقيف المريض وذويه بذلك مسؤولية التمريض المسؤولة عن المريض.
- اختبار القبول عند الشراء وتقييم المخاطر (تحليل نمط الفشل والتأثيرات "FMEA" لتحديد احتمالية حدوث أخطار في التوصيل عند شراء قساطر وأنابيب جديدة

## الغرض

- ضمان الأمان والسلامة للمريض طوال فترة تركيب جميع الوصلات المتصلة بالمريض والتأكد من سلامة الوصلات والبيانات التي يجب وضعها على الوصلة

## التعريفات

- تتبع الوصلة: أي تتبع الوصلة من المريض حتى نقطة الانتهاء من الوصلة للمريض
- التوصيل الخاطئ للقساطر والأنابيب: سوء توصيل أو انفصال الوصلات المتصلة بالمريض
- أنواع الأنابيب والقساطر على سبيل المثال وليس الحصر
  - القساطر الوريدية الطرفية والمركزية.
  - أنبوبة الصدر.
  - الرايل.
  - الأنبوبة الحنجرية.
  - القسطرة البولية.
  - أنبوبة كلى خارجية.
  - درنقة (أنابيب التصريف).
  - الوصلة الشريانية.
  - وصلات الغسيل البريتوني.
  - توصيلات جهاز التنفس الصناعي
  - قسطره بورتاكاس
  - الشق الحنجري
  - وصلات الأكسجين.

١. يلتزم العاملون بضرورة تمييز القساطر عالية الخطورة، تجنب استخدام القساطر ذات منافذ الحقن في تطبيقات تلك القساطر.

○ القساطر عالية الخطورة

| اسم الوصلة                | المسئول عن التركيب |
|---------------------------|--------------------|
| القساطر الوريدية الطرفية  | الأطباء والتمريض   |
| القساطر الوريدية المركزية | الأطباء            |
| انبوبه صدرية              | الأطباء            |
| انبوبه حنجريه             | الأطباء            |
| انبوبه كلويه              | الأطباء            |
| درنقه                     | الأطباء            |
| القسطرة البولية (فولي)    | الأطباء            |
| انبوبه شق حنجري           | الأطباء            |
| قسطرة شريانية             | الأطباء            |
| قسطرة نخاعية              | الأطباء            |
| قسطرة ابيديورال           | الاطباء            |

٢. يتم التنبيه على أهمية عدم الحقن بالقساطر المذكورة وعدم استخدام قساطر بها منافذ حقن في التطبيقات التي

تستوجب قساطر عالية الخطورة

٣. في حالة تركيب أي من الوصلات عالية الخطورة يقوم أعضاء الفريق الطبي المسؤول عن التركيب بتمييز الوصلة

عالية الخطورة باللون الأحمر

٤. يتم كتابة القائم بالتركيب على الوصلات الداخلية للمريض واي من الوصلات خارجه من المريض يتم كتابة اسم

المريض رباعي ورقم الموحد والقائم بالتركيب

٥. يوجد نموذج التأكد من سلامة الوصلات بكل قسم لجميع القساطر والأنابيب موضحا فيها:

○ التأكد من سلامة التركيب.

○ ميعاد نزع الوصلة أو الحالات التي يجب فيها نزع الوصلة أو تغييرها بأخرى.

٦. يقوم مشرف التمريض بتدريب جميع التمريض عن كيفية التعامل مع جميع الوصلات والتأكد من إتقان المهارات التمريضية.

٧. تقوم الممرضة بترتيب الوصلات والقساطر بحيث تبعد عن بعضها

٨. تقوم مشرفة القسم بمتابعة التمريض وتقييمه والتأكد من قدرته على التعامل الآمن مع جميع الوصلات المتصلة بالمريض.

٩. يقوم الطبيب قبل تركيب الوصلة أو القسطرة بفحصها من الجزء الذي يتم به الإدخال حتى نهاية الوصلة للتأكد من سلامة الوصلة.

١٠. يقوم الطبيب بإتباع إجراءات التركيب السليمة طبقا لنوع الإجراء وسياسات مكافحة العدوى.

١١. يقوم الطبيب بالتأكد من الإدخال السليم ومن أن الوصلة أو القسطرة تعمل جيدا وفي المكان السليم على سبيل المثال وليس الحصر التصوير بالأشعة كما في تركيب القسطرة الوريدية المركزية.

١٢. يقوم الطبيب بتثبيت الوصلة أو القسطرة التي تم تركيبها بما يضمن عدم فكها وسهولة التعامل معها.

١٣. يتم تمييز الوصلة التي تم تركيبها بواسطة القائم بتركيب الوصلة سواء كان الطبيب أو التمريض بوضع عنوان عليها تحتوي على (تاريخ التركيب نوع القسطرة، القائم بالتركيب، وقت التركيب).

١٤. في حالة وجود أكثر من درنقة خارجة من الجرح يكتب المكان الذي تخرج منه هذه الدرنقة وتحديد (يمين أو يسار)

١٥. إعلام المريض أو ذويه أو أي من العاملين في غير الفريق الطبي في حالة وجود أي انفكاك للوصلة أو القسطرة الإبلاغ فورا لطلب المساعدة

١٦. تقوم الممرضة المسؤولة بمتابعة التركيبات والوصلات المتصلة بالمريض وملاحظة أي انفكاك أو تغير في

مكان تركيب الوصلات وتسجيل ذلك يوميا بنموذج متابعة التركيبات والوصلات.

١٧. يتوجب على الممرضة تتبع كل الوصلات للتأكد من عدم وجود أي ثنيات والتأكد من صحة التركيب قبل إعطاء

أي دواء وقبل وبعد عمل أي إجراء طبقا للسياسة الخاصة بكل نوع.

١٨. في حالة انفكاك أي من الوصلات أو القساطر يتم كتابة تقرير OVR طبقا لسياسات الجودة

١٩. أثناء عملية التسليم والتسلم بين نوبتجيات التمريض، أو عند نقل المريض من قسم لآخر (مثل النقل من الإفاقة

للقسم الداخلي)، يجب على الممرضة المسلمة والمستلمة القيام بتتبع ومراجعة (Reconciliation) لجميع

الوصلات والقساطر الموجودة بالمريض (من المنشأ إلى الطرف) كجزء أساسي من عملية التسليم، والتأكد من

ثبيتها وتوصيلها بشكل صحيح وتوثيق ذلك.

٢٠. ملحوظة:

- يمنع التعامل مع الوصلات أو إعادة التركيب في غرفة مظلمة لتجنب التوصيل الخطأ.
- يتم الالتزام بمدد التركيب للوصلات كما في نموذج التردد اليومي للتركيبات والجروح.

### المسؤول عن التنفيذ

- الأطباء
- أعضاء هيئة التمريض

### المراقبة والتقييم

- KPI : يتم عمل كارت لمؤشر له علاقة بعملية مرتبطة بالسياسة مع متابعة تحقيق الهدف المراد و نسبته الناتجة من قيمة المؤشر عند القياس لضمان التحسين المستمر
- تقوم المستشفى بتتبع وجمع وتحليل والإبلاغ عن البيانات المتعلقة بتفادي التوصيل غير السليم للقساطر والأنابيب
- تعمل المستشفى على فرص التحسين المحددة في عملية تفادي التوصيل غير السليم للقساطر والأنابيب

## النماذج / المرفقات

- نموذج متابعة التركيبات.
- نموذج أحداث غير متوقعة.
- نموذج التثقيف الصحي
- نموذج ملاحظات التمريض

## معايير ذات صلة

ACT.08 Handover communication; OGM.10 Supply Chain Management.

## المراجع

دليل معايير اعتماد المستشفيات - الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) ، إصدار ٢٠٢٥ . معيار CSS.03



الهيئة العامة للتأمين الصحي  
 رقم: .....  
 القسم المعالج : .....  
 المستشفى:

اسم المريض : .....  
 رقم الملف الطبي للمريض: .....  
 القسم المعالج : .....

### ملاحظات التمريض

|                                                                         |                               |                                    |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| التاريخ: ...../...../.....                                              |                               | القسم: ..... الطبيب المعالج: ..... |                                      |
| التشخيص: .....                                                          |                               | الملاحظات                          |                                      |
| الوقت                                                                   | الوضع الحالي للمريض Situation |                                    |                                      |
|                                                                         | O واعى                        | O غير واعى                         | O واعى ودخل حيز الخطورة لفقدان الوعي |
|                                                                         | الوصلات                       | O نعم                              | نوع الوصلات :                        |
| Background                                                              |                               |                                    |                                      |
| ما تم خلال الشيفت                                                       |                               |                                    |                                      |
| تقييم المريض Assessment يتم الرجوع لنموذج إعادة التقييم التمريضي اليومي |                               |                                    |                                      |
| Recommendation توصيات الشيفت القادم                                     |                               |                                    |                                      |
| توقيع التمريض المستلم: .....                                            |                               |                                    |                                      |
| توقيع التمريض المستلم: .....                                            |                               |                                    |                                      |
| التاريخ: ...../...../..... الوقت: .....                                 |                               |                                    |                                      |



الهيئة العامة للتأمين الصحي  
 فرع: .....  
 المستشفى: .....  
 اسم المريض: .....  
 رقم الملف الطبي للمريض: .....  
 القسم المعالج : .....

### التثقيف الصحي للمريض

التاريخ: / / القسم: .....  
 تقييم مبدئي للاحتياجات التعليمية للمريض / الأسرة ( هذا الجزء يملأ بمعرفة التمريض )  
 -التعليم :  
☐ مؤهل على ☐ مؤهل متوسط ☐ يقرأ ويكتب ☐ أمى  
 -الحالة النفسية والقابلية للتعلم : ☐ يريد ويستجيب ☐ لا يريد ولا يستجيب  
 -عوائق للتثقيف :  
☐ عضوية ( السمع - الكلام ) ☐ معرفية ( مستوى الذكاء والإستيعاب )  
 - بناءاً على المعلومات السابقة سيتم تقديم التثقيف لـ ☐ المريض ☐ الأسرة  
 - طريقة التثقيف : ☐ شفاهة ☐ مكتوبة  
☐ أخرى ( اذكر ) .....  
 - شرح من قبل كوادى أخرى . ( حدد ) : .....

| شرح من قبل الطبيب                                                             | تم | التوقيع |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| هل تم شرح التشخيص الطبي ؟                                                     |    |         |
| هل تم شرح طريقة العلاج والآثار الجانبية ؟                                     |    |         |
| هل تم شرح الإجراءات والفحوصات المطلوبة قبل اجراءها ؟                          |    |         |
| هل تم شرح التفاعل الدوائى الغذائى ؟                                           |    |         |
| التأهيل الوظيفى ( العلاج الطبيعى ) عند الحاجة                                 |    |         |
| هل هناك حاجة لحضور برنامج تثقيفى اضافى ؟                                      |    |         |
| هل تم شرح تعليمات الخروج والمتابعه ؟                                          |    |         |
| هل تم شرح واستيعاب وفهم تعليمات الخروج والمتابعة ؟                            |    |         |
| شرح من قبل التمريض                                                            |    |         |
| هل تم شرح اهمية ارتداء اسورة التعريف ؟                                        |    |         |
| هل تم شرح تعليمات العناية بالقسطر والوصلات؟                                   |    |         |
| هل تم شرح احتياطات منع خطر السقوط؟                                            |    |         |
| هل تم شرح اجراءات الوقاية من قرح الفراش؟                                      |    |         |
| شرح النظام الغذائى و تقليل المخاطر مثل التدخين وأهمية الرياضة والنظام الغذائى |    |         |

تم شرح التثقيف الصحي :  
 توقيع المريض : ..... التاريخ: / / الوقت : .....  
 MR.Imp.Dr.1-1

نموذج الأحداث غير المتوقعة

الهيئة العامة للتأمين الصحي  
 اسم المريض : .....  
 رقم الملف الطبي للمريض : .....  
 القسم المعالج : .....  
 مستشفى : .....



**جدول متابعة التراكيبات**

تاريخ الدخول: / /

**التراكيبات :**  
 1- كاتوبولا طرفية CVP -2 أنبوبية رايلا 3 - قسطرة بولية 4 - أنبوبية حنجرية  
 5- أنبوبية صدرية 6- أنبوبية رايلا 7- كاتوبولا شرياني 8- أخرى

| النوع | مكان التركيب | تاريخ التركيب | ساعة التركيب | توقيع القاتم بالتركيب | تاريخ التغيير | ساعة التغيير | سبب التغيير | توقيع القاتم بالتغيير |
|-------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------|
|       |              |               |              |                       |               |              |             |                       |
|       |              |               |              |                       |               |              |             |                       |
|       |              |               |              |                       |               |              |             |                       |
|       |              |               |              |                       |               |              |             |                       |
|       |              |               |              |                       |               |              |             |                       |
|       |              |               |              |                       |               |              |             |                       |
|       |              |               |              |                       |               |              |             |                       |
|       |              |               |              |                       |               |              |             |                       |
|       |              |               |              |                       |               |              |             |                       |
|       |              |               |              |                       |               |              |             |                       |

MR Nu 7

الهيئة العامة للتأمين الصحي  
 فرع : .....  
 مستشفى : .....



**OCCURRENCE VARIANCE REPORT (OVR)**

**OVR Code No. (.....)**

THIS FORM SHOULD BE FORWARDED TO THE QUALITY DEPARTMENT WITHIN 72 HOURS

يجب أن يسلم النموذج لقسم الجودة في خلال 72 ساعة

|                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Reported by Name (OPTIONAL):<br>اسم المبلغ (اختياري) | Department:<br>القسم                |
| Reported by Signature:<br>توقيع المبلغ               | Date of Reporting:<br>تاريخ التبليغ |

**INDIVIDUAL OR MEMBER OF STAFF INVOLVED (Tick One or More)**

☐ Nurse ممرضة  
☐ Physician طبيب  
☐ Administrative إداري  
☐ Patient مريض  
☐ Nursing Assistant مساعدين  
☐ Technician فني  
☐ Security فرد أمن  
☐ Other أخرى

**OCCURRENCE INFORMATION**

|                                             |                                     |                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Date of Incident<br>تاريخ الحادث            | Time of Incident<br>وقت وقوع الحادث | Location/Unit<br>الوحدة/المكان                                            |
| Name of Person Involved<br>اسم الشخص المعني | Patient ID:<br>رقم الملف الطبي      | <input type="checkbox"/> Female أنثى<br><input type="checkbox"/> Male ذكر |

Briefly describe the incident/ occurrence and attach the supporting data when applicable

وصف ملخص للحادث مع الدعم بمستند إذا أمكن

Immediate Corrective Action taken: To be completed by involved/concerned department  
 الإجراء التصحيحي المتخذ : يتم كتابته من قبل الشخص المسئول

Suggested Preventive Action: To be completed by the concerned Head of Department for follow up  
 الإجراء التصحيحي المقترح : يتم كتابته من قبل رئيس القسم المعن

Name: ..... Date: ..... Time: ..... Signature: .....

O.V.R. 1-2